

Resumen para el historial

Sesión N° 1, [fecha xx/xx/xxxx]

La sesión corresponde a un primer contacto clínico con una consultante que se presenta con dificultades marcadas para reincorporarse al mercado laboral tras aproximadamente diez años dedicados al cuidado de sus tres hijos. Refiere que lleva un año intentando dar ese paso sin lograrlo, y que el solo hecho de proponérselo activa una cascada de pensamientos negativos que la bloquea antes de iniciar cualquier acción concreta: hasta el momento no ha llegado a abrir el documento de su currículum.

El motivo de consulta se articula en torno a la experiencia subjetiva de bloqueo, miedo e inutilidad ante la perspectiva de buscar empleo. La consultante describe sensaciones físicas de calor corporal y ansiedad creciente en cuanto se dispone a actuar, y refiere que cuanto más intenta concretar la tarea, más intensos y frecuentes se vuelven los pensamientos interferentes.

En el trabajo de identificación cognitiva realizado durante la sesión, emergieron con claridad varios pensamientos automáticos expresados de forma textual: "no voy a poder", "para qué quiero hacer esto", "estoy fuera" y "ya no tiene más sentido". La consultante también verbalizó la preocupación de que los demás la verán como insuficiente por haber estado diez años fuera del mercado, y que "cuando uno ya es mayor no sé si se puede aprender". Como creencia nuclear organizadora del conjunto, identificó espontáneamente —en respuesta a la metáfora del capitán del equipo— la idea "no soy suficiente", tanto referida a sí misma como a la percepción que otros tendrían de ella. Como segundo elemento central, articuló la creencia de que intentarlo equivale a "sentirme un fracaso", lo que actúa como predicción catastrófica que inhibe cualquier acción. Ella misma señaló que esta creencia no es nueva: antes de dejar el trabajo la compensaba con conductas de rendimiento excesivo ("yo siempre era la que llegaba antes, yo siempre era la que terminaba todo antes"), lo que sugiere una historia de afrontamiento basado en el desempeño para sostener la autoestima.

A nivel conductual, el patrón principal identificado es la evitación activa de la tarea (no abrir el currículum) sostenida por la rumiación: la consultante salta de un pensamiento a otro de manera acelerada, lo que incrementa la ansiedad, refuerza la sensación de estar "estancada y derrotada" y aleja aún más la conducta-meta. Este ciclo lleva aproximadamente un año de instalación. La consultante reconoció que este patrón no ha producido ningún avance y que, proyectado a otro año, implicaría consecuencias que le resultan inaceptables: mayor distancia emocional con sus hijos, rencor hacia su pareja y profundización del malestar general. La exploración de estas consecuencias funcionó como motivador significativo, con visible impacto emocional cuando mencionó a sus hijos, hacia quienes refirió un vínculo de alta importancia.

La intervención principal de la sesión se enmarcó en técnicas de defusión cognitiva de la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT). Se utilizó la escritura de pensamientos en papel y el análisis formal de sus características (número de palabras, letras, uso de mayúsculas o minúsculas) para

crear distancia observadora respecto al contenido cognitivo. Se introdujeron metáforas —el equipo de fútbol con capitán y entrenador, la publicidad televisiva que puede ignorarse— para externalizar y des-literalizar los pensamientos. Se trabajó explícitamente la distinción entre "tener el pensamiento" y "comprar el pensamiento", y se exploró la capacidad de elección como recurso central de la consultante. La consultante respondió favorablemente a estas intervenciones, mostrando capacidad de mentalización sobre sus propios procesos cognitivos y adoptando el lenguaje de la sesión con relativa fluidez.

Como tarea acordada para la semana siguiente, la consultante se comprometió a abrir su currículum, leerlo, revisarlo y actualizarlo, con la instrucción de anotar los pensamientos interferentes que aparezcan —en lugar de seguirlos— y continuar con la tarea. Anticipó que los pensamientos volverán y verbalizó espontáneamente la estrategia de observarlos escritos antes de retomar la acción.

Como recursos personales destacados: la consultante muestra alta motivación hacia el cambio, conciencia del costo de sus patrones actuales, vínculos significativos que funcionan como valores orientadores, y capacidad de engancharse rápidamente con nuevas formas de relacionarse con sus pensamientos cuando se le ofrece un marco concreto.

El proceso se encuentra en su fase inicial. Los principales factores de mantenimiento identificados son la fusión cognitiva con pensamientos de insuficiencia y predicción de fracaso, la evitación conductual de la tarea y la rumiación acelerada que impide tanto la acción como la regulación emocional. El trabajo clínico prioritario para las sesiones siguientes incluye la consolidación de habilidades de defusión, la exploración más sistemática de la creencia nuclear de insuficiencia y su historia de desarrollo, y el acompañamiento de la exposición conductual gradual a las tareas de búsqueda de empleo en un marco de valores.